

1. Neurologie

- PC = 35cm à terme
- PC > 35cm : macrocéphalie (volume cérébral ou LCR) due à un trouble de la résorption du liquide (pas de signes neurologiques), hydrocéphalie (hypertension intracrânienne, fontanelles bombées, regard en soleil couchant)
- PC < 35cm : microcéphalie (développement cérébral ou destruction par AVC, trauma)
- tonus : au repos, passif et actif
- force : mouvement contre gravité, tiré-assis, port de tête, etc.

2. Pleurs

- normaux ou non ?
- apparence, respiration, circulation
- status complet (neurologique, respiratoire, cardiaque, ORL, oculaire, abdomen, cutané, uro-génital, ostéo-articulaire)

3. Fièvre

- anamnèse
- identifier les red flags (troubles neurologiques, signes de choc comme tachycardie et extrémités froides, signes d'infection)

4. Anamnèse

- PQRST : provocation/palliation, qualité/quantité, région/irradiation, sévérité, temporalité
- cardio-pulmonaire : dyspnée, sudation, toux, respiration
- ORL : rhinorrhée, douleurs oreilles
- abdominale : vomissements, urines, selles
- cutanée : rash
- général : fièvre, poids, sommeil, alimentation, comportement

5. Réanimation

- évaluation primaire ABCDE
- A : airway = voies aériennes (libres, libres avec aide comme aspiration, chin lift, intubation, ventilation assistée au ballon)
- B : breathing (FR, tirage comme battement ailes du nez, balancement thoraco-abdominal, ampliation thoracique, stridor, sibilances, grunting, couleur de la peau, saturomètre)
- C : circulation (FC, rythme, pouls centraux et périphériques, TRC, couleur de la peau, TA, perfusion du cerveau, de la peau et débit urinaire)
- choc compensé : FC augmentée, mauvaise perfusion périphérique
- choc décompensé : pouls centraux faibles (carotidien, fémoral, brachial, axillaire), diminution de l'état d'éveil, hypotension
- D : évaluation de l'état de conscience (Awake/Voice responsive/Pain responsive/Unresponsive), pupilles (stimulation lumineuse, myosis/mydriase, position)
- E : exposure (trauma, brûlure, hémorragie, atteinte cutanée, température, prévenir l'hypothermie et immobiliser la colonne cervicale si suspicion de trauma)
- évaluation secondaire SAMPLE

- S : signes et symptômes
- A : allergies
- M : médicaments
- P : passé, antécédents
- L : last meal
- E : événements amenant à la présentation

Identifier Etat physiopathologique et/ou diagnostic

	Type	Sévérité
Respiratoire	•Obstruction VAS •Obstruction VAI •Maladie du tissu pulmonaire •Désordre du contrôle de la respiration	•Détresse respiratoire •Insuffisance respiratoire
Circulatoire	•Choc hypovolémique •Choc distributif •Choc cardiogénique •Choc obstructif	•Choc compensé •Choc décompensé (hypotension)
Insuffisance cardio- respiratoire		
Arrêt cardiaque		

Classier l'obstruction des Voies Aériennes (Résumé)

- Obstruction Haute:
 - Signes de détresse
 - « Tirage » surtout sus- sternal
 - Bruit: Stridor
- Obstruction Basse:
 - Signes de détresse
 - « Tirage » intercostal plutôt
 - Balancement thoraco- abdominal
 - Bruit:
 - Sifflement, sibilances, wheezing: syndrome obstructif (« asthme »)
 - Grunting: syndrome restrictif (« pneumonie »)

Bruits pulmonaires	Continu	Intermittent
Inspiratoire	Stridor	Râles = crackles
Expiratoire	Sibilances = wheezing	Ronchi

Grunting
= pneumonie

Bruits hauts transmis
= sécrétions nasales

Toux aboyante =
larynx